

Estado Epiléptico:

Dr Danilo Sánchez Coronel



¿Qué es el Estado Epiléptico (EE)?

Definición clínica: Crisis epiléptica que dura más de 5 minutos o múltiples crisis sin recuperación completa de la conciencia entre ellas.

Representa una **emergencia neurológica** con alta morbimortalidad que requiere intervención terapéutica inmediata.





Clasificación Clínica del Estado Epiléptico

EE Convulsivo

Crisis tónico-clónicas generalizadas prolongadas o repetidas con manifestaciones motoras evidentes.

EE No Convulsivo

Alteración persistente del nivel de conciencia sin convulsiones visibles, requiere confirmación electroencefalográfica.

EE Focal

Con o sin alteración de conciencia, puede presentar síntomas motores, sensitivos o psíquicos localizados.

La diferenciación clínica es **fundamental** para establecer el protocolo terapéutico apropiado y determinar el pronóstico neurológico.

Fisiopatología: Bases Neurobiológicas del EE

01

Descarga Neuronal Patológica

Actividad eléctrica excesiva, brusca e hipsincrónica de poblaciones neuronales corticales que supera los mecanismos reguladores normales.

02

Desequilibrio Neurotransmisor

Fallo progresivo de los mecanismos inhibitorios GABAérgicos con predominio de la excitación glutamatérgica patológica.

03

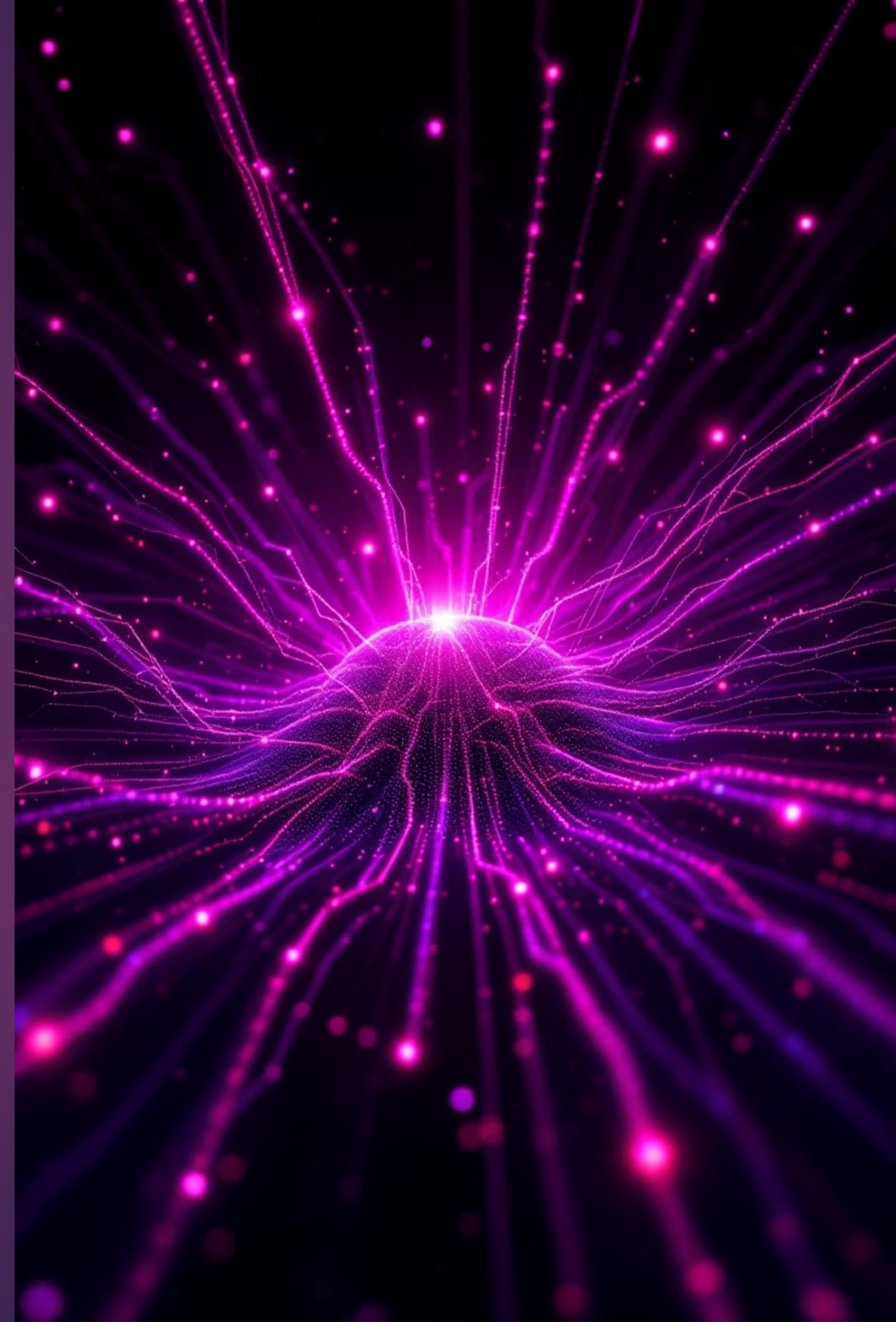
Alteraciones Metabólicas

Hipoxia cerebral regional, disregulación del flujo sanguíneo cerebral y inicio del daño neuronal progresivo e irreversible.

04

Fallo Compensatorio

Los mecanismos neuroprotectores endógenos se agotan tras 20-40 minutos, aumentando exponencialmente el riesgo de secuelas.





Tiempo Crítico en el EE

Conceptos Tiempo 1 y Tiempo 2 (ILAE 2015)

Tiempo 1: 5 minutos

EE Convulsivo: Momento crítico para iniciar tratamiento farmacológico inmediato y prevenir progresión del daño neurológico.

1

2

Tiempo 2: 30 minutos

EE Convulsivo: Umbral temporal donde el riesgo de daño neuronal permanente e irreversible aumenta de forma significativa.

❏ **Tiempos específicos:** Para EE focal (10-15 min) y crisis de ausencia (>60 min), los intervalos temporales críticos son diferentes y requieren adaptación protocolaria.

Etiologías Comunes del Estado Epiléptico



Epilepsia Preexistente

Control inadecuado de epilepsia conocida, abandono o modificación de medicación antiepiléptica, interacciones farmacológicas.



Alteraciones Metabólicas

Hipoglucemia severa, hiponatremia, uremia, encefalopatía hepática o trastornos del equilibrio ácido-base.



Lesión Cerebral Aguda

Accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, encefalitis, meningitis o hemorragia intracraneal.



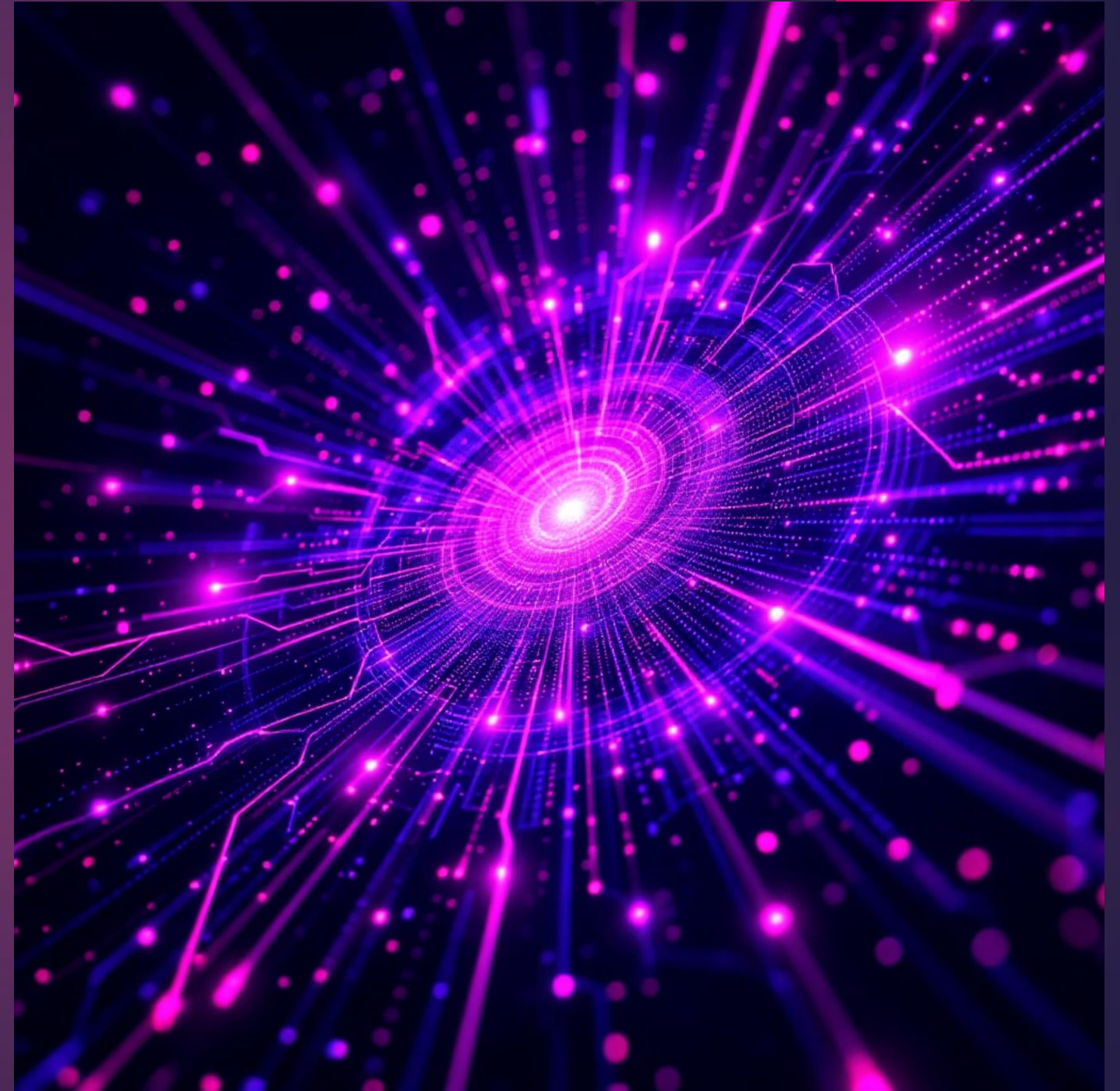
Otras Causas

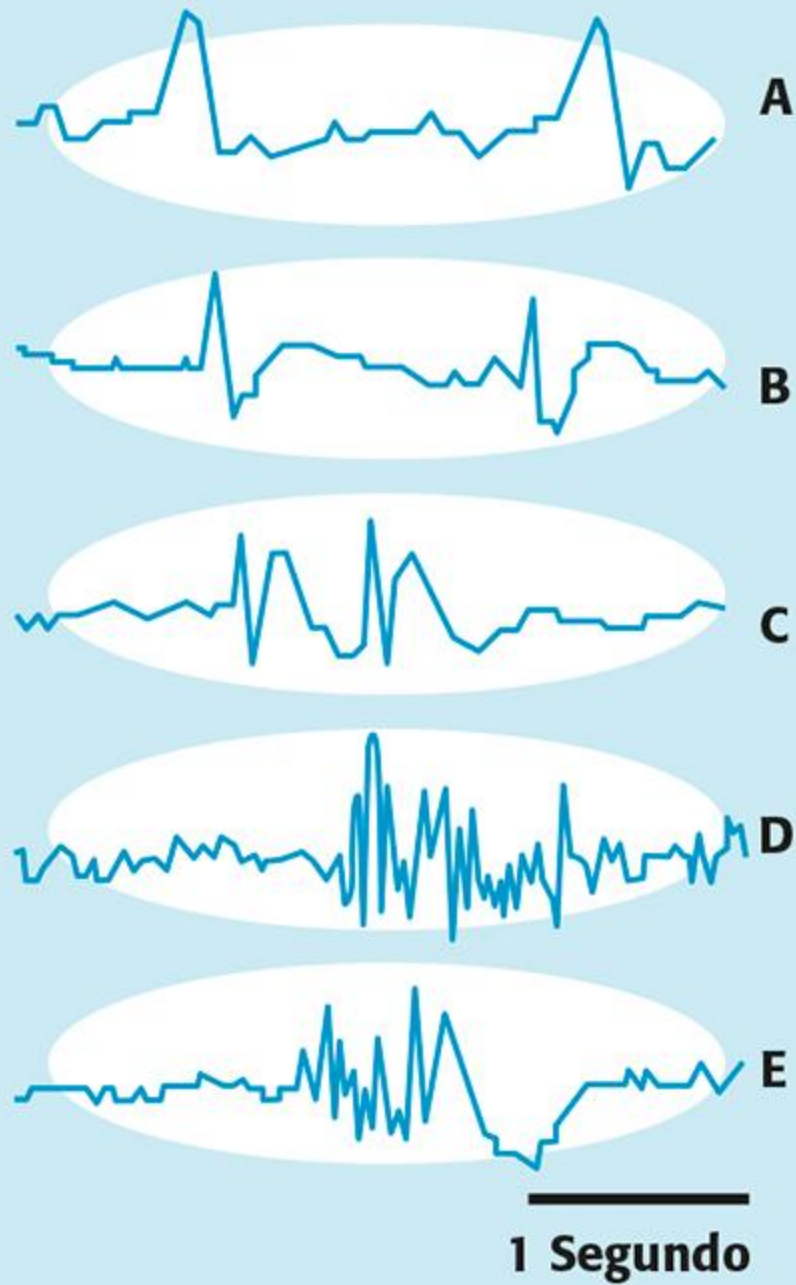
Neoplasias cerebrales, intoxicaciones por drogas o fármacos, síndrome de abstinencia y causas idiopáticas.

Diagnóstico Clínico y Electroencefalográfico

Evaluación Clínica

- Reconocimiento precoz basado en manifestaciones clínicas
- Convulsiones de duración prolongada (>5 min)
- Alteración persistente del estado de conciencia
- Ausencia de recuperación intercrítica completa





- A.** Onda aguda: Potencial paroxístico morfología puntiaguda de 70-200 mseg. duración. **B.** Punta: Potencial paroxístico puntiagudo < 70 mseg. **C.** Complejo de Punta-onda: Punta seguida de onda lenta (frecuencia variable 2-5 Hz). **D.** Polipunta: Serie de múltiples puntas a frecuencia rápida. **E.** Polipunta-onda: Complejo de múltiples puntas seguidas de onda lenta.

Figura 3. Principales descargas epileptiformes.

Proia, Angelo E. ID paciente: No124

TT 00:20:46,0 27/09/2003 03:00:00 p.m.

Montaje: MONTAJE 8 Corte Alta Frecuencia: 70 Hz Corte Baja Frecuencia: 0,53 Hz Sensibilidad: 20 μ V/mm Velocidad: 15,0 mm/s



Figura 2

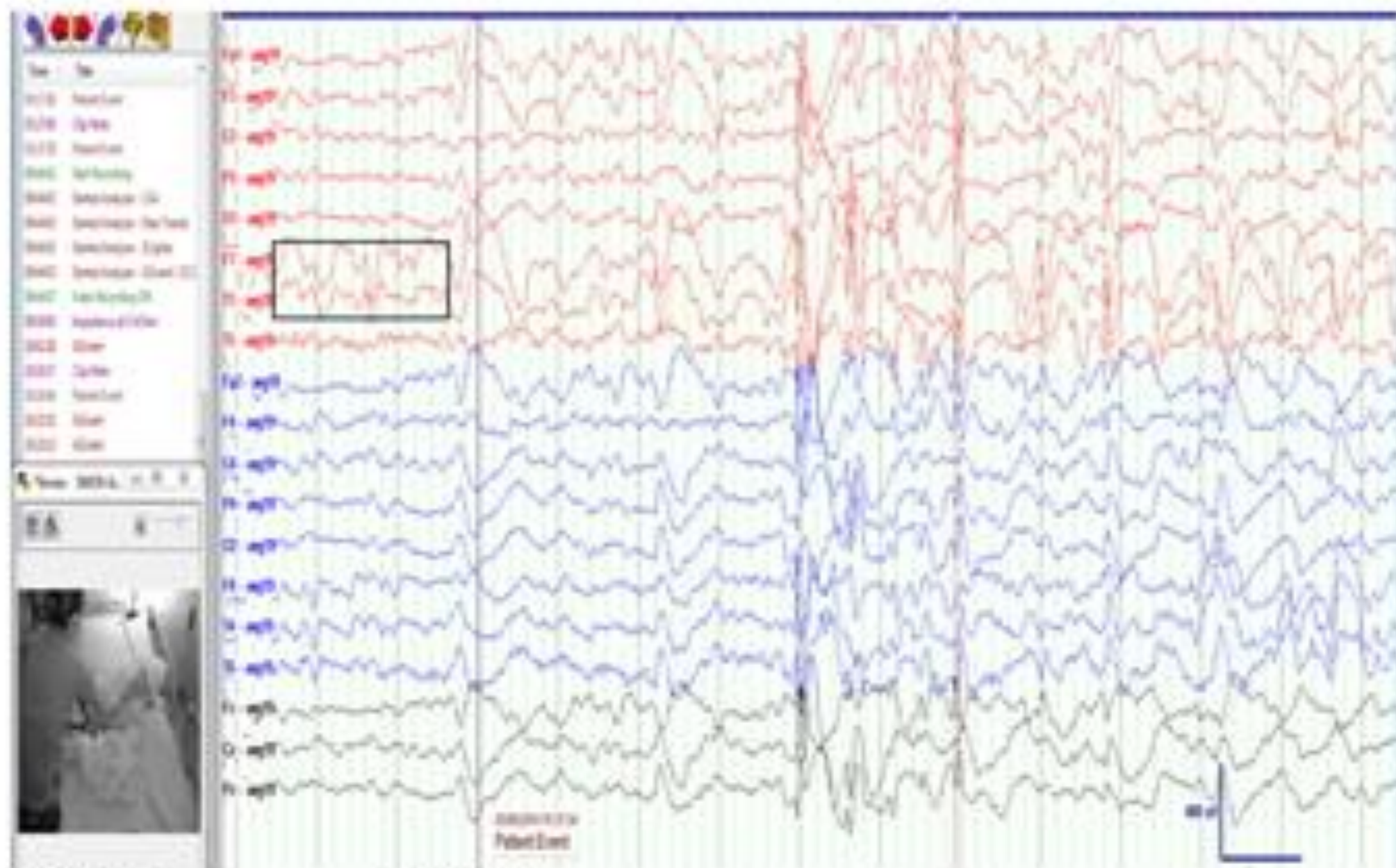
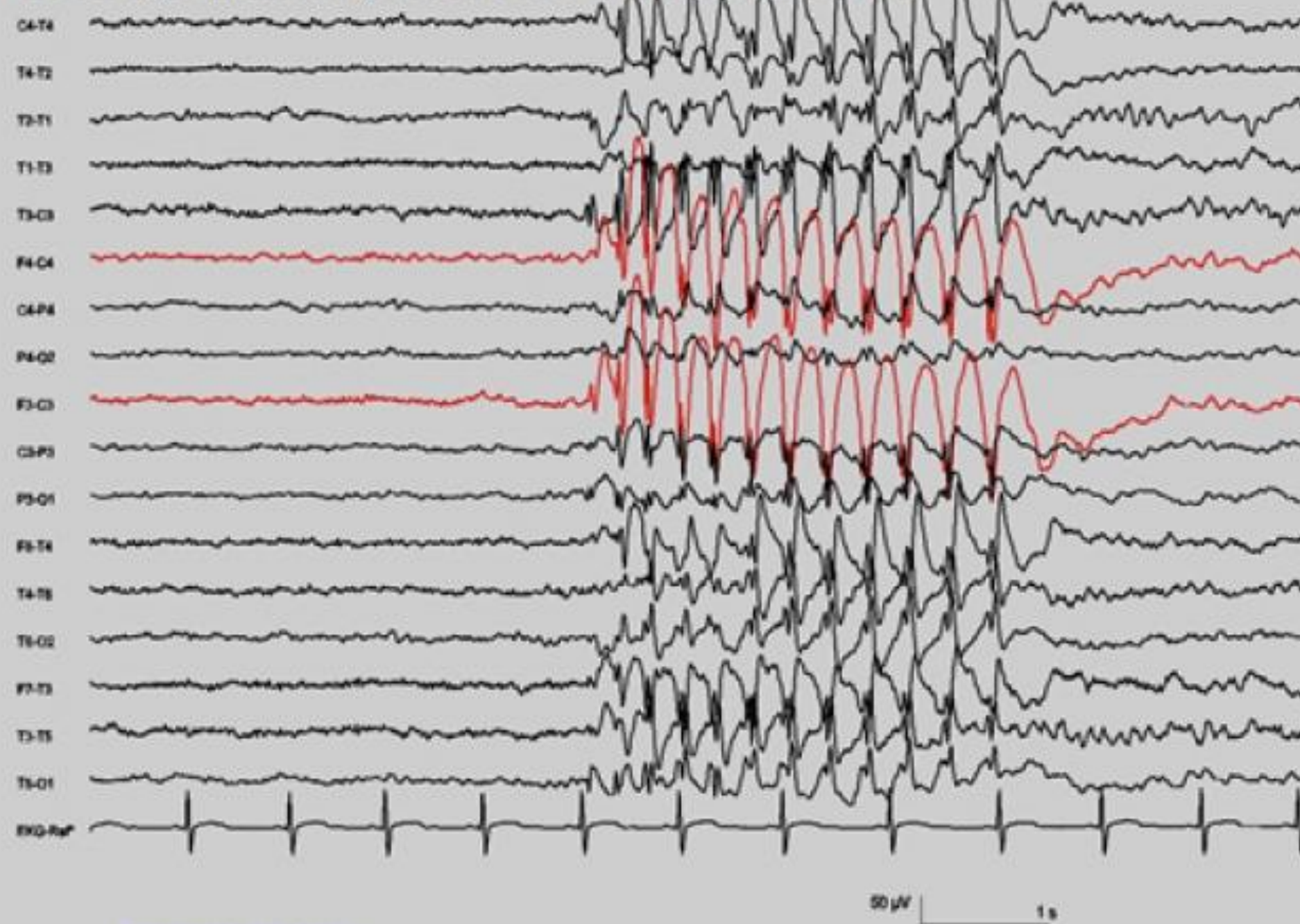


Fig. 5

CRISIS

Descarga interictal generalizada: Punta-onda a 3 Hz



EEG 2020-08-10-01

Tratamiento Inicial y Protocolos Actuales

Primera Línea (0-5 min)

Benzodiacepinas: Diazepam IV (0,15-0,2 mg/kg) o Lorazepam IV (0,1 mg/kg). Inicio inmediato tras identificación del EE.

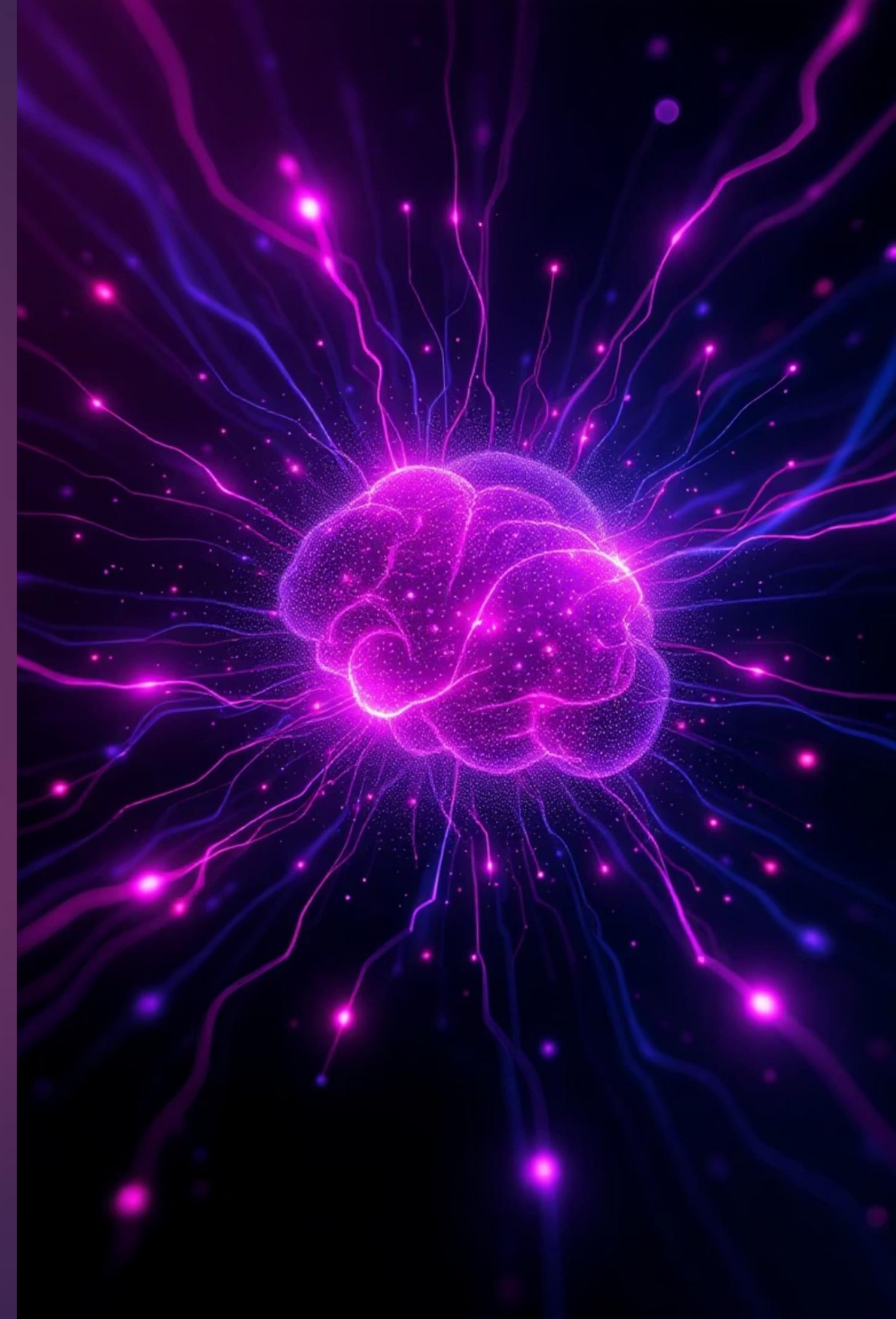
Segunda Línea (5-20 min)

Antiepilépticos IV: Fenitoína (20 mg/kg), Ácido Valproico (40 mg/kg) o Levetiracetam (60 mg/kg) según disponibilidad y contraindicaciones.

EE Refractario (>20 min)

Anestésicos IV: Propofol, Midazolam o Pentobarbital con monitorización intensiva y soporte ventilatorio en UCI.

❏ Los **protocolos estandarizados** y la implementación sistemática mejoran significativamente el pronóstico neurológico y reducen la morbilidad asociada.

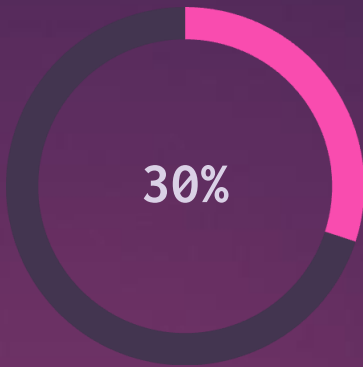


Pronóstico y Complicaciones



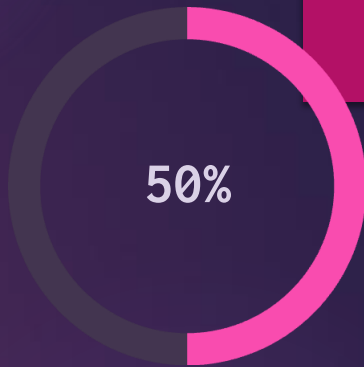
Mortalidad

Incremento respecto a población general



Secuelas

Deterioro cognitivo permanente



Recurrencia

Riesgo en etiología orgánica

Factores Pronósticos

- Duración del estado epiléptico
- Edad del paciente al momento del episodio
- Etiología subyacente identificada
- Tiempo hasta inicio del tratamiento



Conclusión: Claves para el Manejo del Estado Epiléptico

Urgencia Neurológica

El EE constituye una emergencia que requiere diagnóstico rápido y tratamiento inmediato para prevenir daño neurológico irreversible.

Comprensión Fisiopatológica

El conocimiento profundo de los mecanismos subyacentes permite optimizar las estrategias terapéuticas y prevenir el daño cerebral progresivo.

Protocolos Estandarizados

La implementación de protocolos claros y monitorización continua son fundamentales para mejorar supervivencia y calidad de vida.

La **actualización constante** según las guías clínicas internacionales y la evidencia científica emergente constituye un imperativo profesional fundamental para todos los neurólogos en la práctica clínica contemporánea.

